

Adénopathies superficielles

Orientation diagnostique

Pr Ag Imen Frikha
25 Août 2025

OBJECTIFS

1. Définir une adénopathie superficielle
2. Reconnaître par l'interrogatoire et l'examen physique, les caractéristiques cliniques d'une adénopathie superficielle
3. Différencier par l'examen clinique, une adénopathie superficielle d'une tuméfaction non ganglionnaire dans la région axillaire, cervicale et inguinale
4. Reconnaître par les données de l'examen clinique, les caractéristiques orientant vers une origine maligne d'une adénopathie superficielle
5. Hiérarchiser les examens complémentaires en fonction des données de l'examen clinique chez un patient présentant une adénopathie superficielle
6. Etablir par l'examen clinique et les examens complémentaires le diagnostic étiologique d'une adénopathie superficielle

Rappel

- Une adénopathie: ↑ du volume d'un ganglion lymphatique dont la **taille > 1 cm**.
- Diagnostic **positif**: par la **palpation**.
- Un diamètre **> à 1 cm** est retenu comme pathologique
- Les ganglions **inguinaux** sont considérés comme physiologiques jusqu'à **1,5-2cm**.
- Les ganglions **épitrochléens** et **sus claviculaires** sont considérés comme pathologiques **qq soit leur taille**.

Une adénopathie est dite **chronique** si la durée d'évolution est **supérieure à 3 semaines**.

Rappel

Interrogatoire

- Date d'apparition, son évolution
- Caractère unique ou multiple
- Mode d'apparition et son évolution spontanée ou sous l'effet d'un traitement
- Douloureuse ou non
- Aspect de la peau en regard
- Taille : stable ou augmentation progressive
- Symptômes associés : AEG (amaigrissement, fièvre, sueurs nocturnes), diarrhée, épistaxis, prurit....

Examen physique

- Toutes les aires ganglionnaires.
- Patient examiné en **position assise** au bord du lit: palper les aires ganglionnaires **cervicales** et **axillaires**
- Puis **position couchée** pour l'abord des aires ganglionnaires **inguinales** et pour l'appréciation du sd tumoral profond (recherche d'une **hépatosplénomégalie**).

Toute **ADP cervicale** impose une palpation de **toutes les autres aires ganglionnaires** et un **examen ORL complet**

Rappel

Diagnostic différentiel

▪ Dans la région cervicale

- Grande corne Hyoïde
- Anévrysme carotidien
- Bulbe carotidien
- Ptose de la glande Submandibulaire
- kystes du tractus thyroïdienne
- Nodules thyroïdiens
- Tumeurs de la parotide
- Tumeurs vasculo-nerveuses
- Kyste branchial
- Lymphangiome kystique ou lipome

▪ Dans la région axillaire

- Hydrosadénite
- Digitations musculaires du grand dentelé
- Tuméfaction costale

▪ Dans la région inguinale

- Hernie inguinale/crurale
- Testicule ectopique
- Kyste du cordon
- Anévrysme vasculaire (pulsatile)

▪ Toute localisation

Lipome , Abscess, Anévrysme (pulsatile), Neurinome, neurofibrome

Rappel

En faveur du caractère malin d'une adénopathie

- Le **caractère compressif**
- La consistance **dure pierreuse** (métastases), **ferme** (hémopathies malignes)
- Adénopathie volumineuse (**>2cm**) et/ou augmentant **rapidement de volume** sans porte d'entrée infectieuse associée
- **L'adhésion aux plans profond et superficiel**
- Le caractère **indolore**, non inflammatoire
- La perte de la forme du ganglion qui devient **mal limité**

Rappel

Adénopathie localisée

- Les examens complémentaires sont **indiqués**:
 - D'absence d'étiologie au terme de l'ex clinique
 - D'altération de l'état général
 - D'adénopathie suspecte de malignité

La **localisation** d'une ADP périphérique isolée joue un rôle essentiel dans la **démarche diagnostique**

Tableau 1 : Territoire de drainage des aires ganglionnaires superficielles

Cervicale	Sous-maxillaire	Langue, glandes sous-maxillaires, lèvres, bouche, conjonctives
	Jugulaire	Langue, amygdales, parotide, pavillon de l'oreille, thyroïde
	Cervical postérieur	Cuir chevelu, cou, peau des bras et pectoraux, ganglions thoraciques, cervicaux et axillaires
	Rétro-auriculaires	Conduit auditif externe, cuir chevelu, pavillon de l'oreille
	Sus-claviculaire droit	Médiastin, poumons, œsophage
	Sus-claviculaire gauche	Thorax, abdomen par le canal thoracique
Axillaire		Bras, paroi thoracique, seins
Epithrochléenne		Face cubitale de l'avant-bras et de la main
Inguinale		Pénis, scrotum, vulve, vagin, périnée, région fessière, partie inférieure de la paroi abdominale, partie inférieure du canal anal.

Rappel

Polyadénopathies

- Démarche étiologique tout à fait différente
- **Bilan de première intention :**
NFS, CRP, bilan hépatique, LDH, Sérologies VIH, EBV, CMV, toxoplasmose et une RX thorax

L'hémogramme (FS): examen d'orientation principal

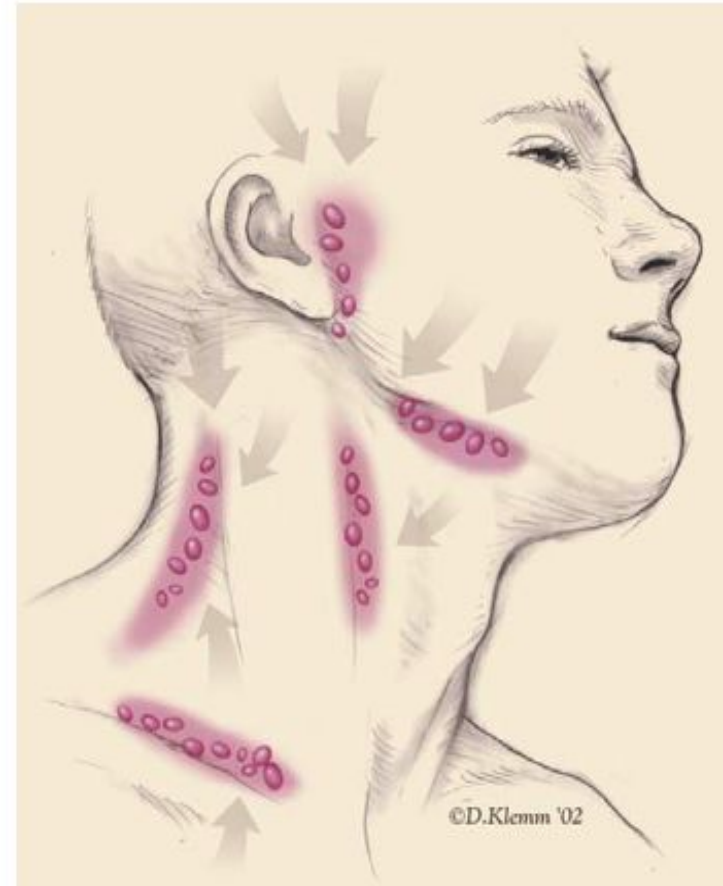
- **Bilan de 2^{ème} intention:**
Sérologie syphilis, bilan immunologique, bilan phospho-calcique et TDM TAP.

En l'absence de cause précise ou devant une ADP suspecte, un examen anatomo-pathologique est indispensable

Territoires de drainage des aires ganglionnaires

Ganglions cervicaux

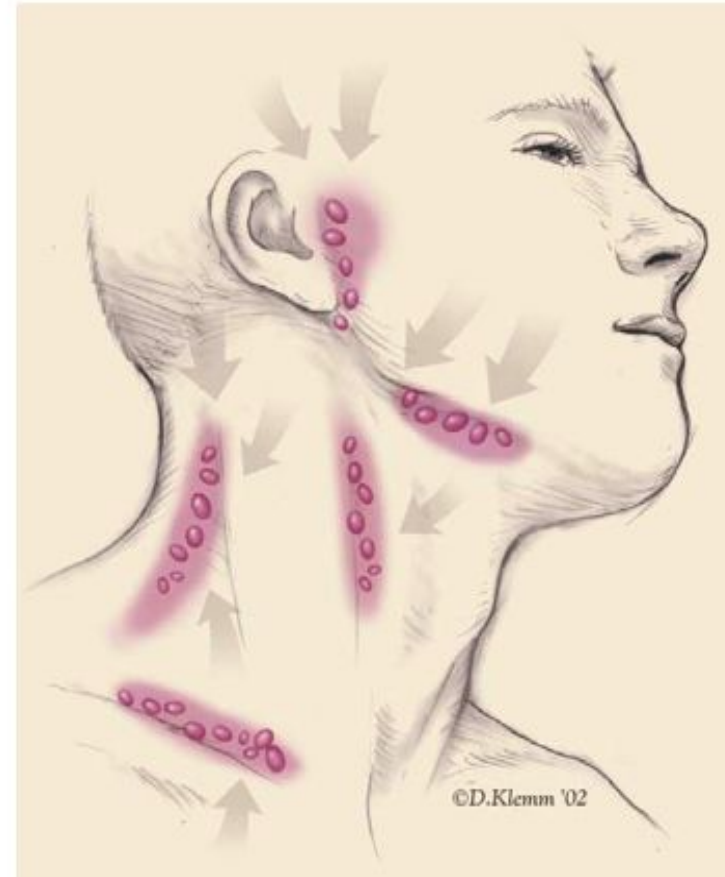
- Périauriculaires drainent le scalp et la peau du haut du visage
 - Infection du scalp et infection mycobactérienne
 - Cancer tête et cou, LNH, cancer de peau
- Cervicaux postérieurs drainent scalp, cou et peau du thorax haut
 - Même dx différentiel que péri-auriculaire



Territoire de drainage des aires ganglionnaires

Ganglions cervicaux

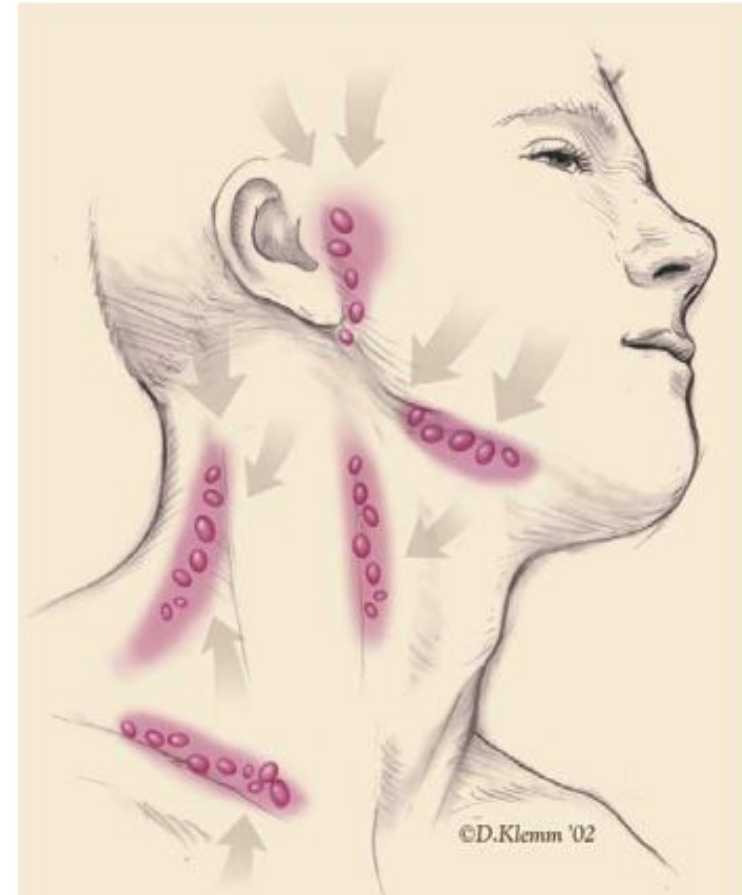
- Sous-mandibulaires drainent la cavité orale
- Cervicaux antérieurs drainent le larynx, la langue, oropharynx et portion antérieure du cou
 - En général infectieux EBV, CMV, infection virale ou bactérienne de la cavité orale, rubéole, problème dentaire, toxoplasmose
 - Cancer tête et cou, leucémie, lymphome.



Territoire de drainage des aires ganglionnaires

Ganglion sus-claviculaire

- Rechercher maladie maligne en premier
- Droit :
 - Habituellement drainage thoracique
- Gauche :
 - Habituellement drainage abdominal



Territoire de drainage des aires ganglionnaires

Ganglion sous-claviculaire

- Rechercher maladie maligne en premier
 - Très suggestif de lymphome



Territoire de drainage des aires ganglionnaires

Ganglions axillaires

- Territoire de drainage du membre supérieur et d'une partie des seins
- Examen des seins et des membres supérieurs
- Éliminer cancer du sein et cancer de la peau. LNH possible



Territoire de drainage des aires ganglionnaires

Ganglions épithrochléen

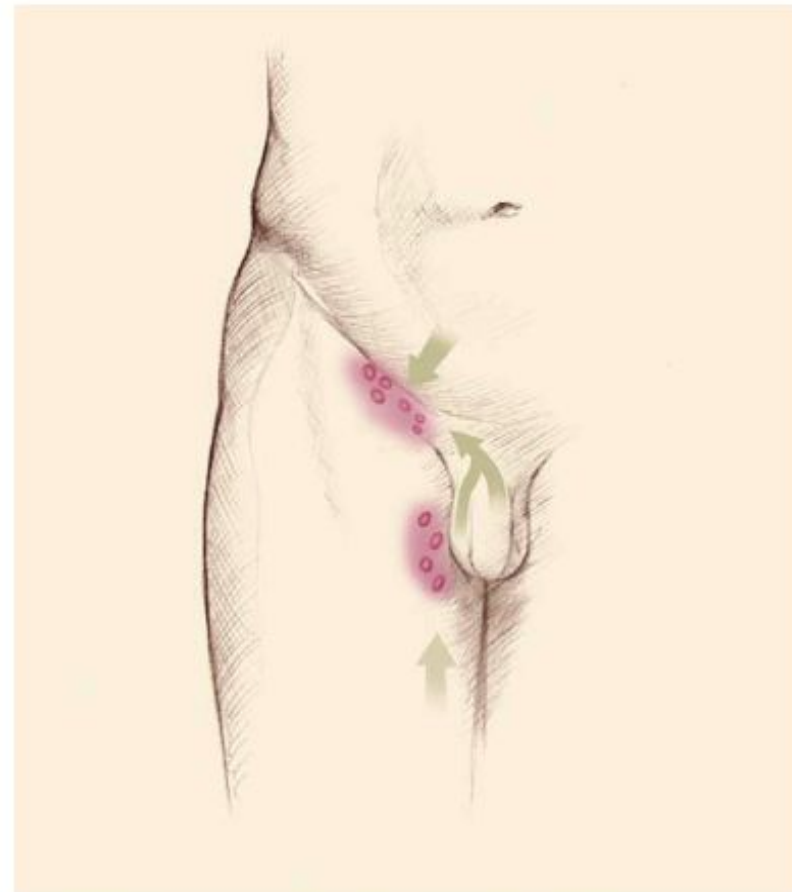
- Territoire de drainage de l'avant-bras
 - Infection
 - Cancer de la peau
 - Lymphome
 - Sarcoïdose



Territoire de drainage des aires ganglionnaires

Ganglions inguinaux

- Normalement palpable chez la majorité des gens, mais seront alors en bas de 1 cm, parfois jusqu'à 2 cm
- Territoire de drainage des organes génitaux externes et des membres inférieurs
 - Éliminer les causes infectieuses en premier telles que ITS
 - Éliminer cancer de la peau, cancer de la vulve, du pénis et de l'anus
 - LNH possible, sarcome de Kaposi



Diagnostic d'une adénopathie superficielle isolée :

<i>siège</i>	<i>rechercher une lésion infectieuse ou tumorale au niveau de :</i>
cervical	sphère ORL, cavité buccale thyroïde cuir chevelu
axillaire	membre supérieur sein
inguinal	membre inférieur organes génitaux externes : pénis, scrotum, vulve région anale
sus-claviculaire	médiastin, bronches étage sous-diaphragmatique : tube digestif testicule

Médicaments et adénopathies

- Allopurinol
- Aténolol
- Captopril
- Carbamazépine
- Sels d'or
- Pénicilline
- Phénytoïne (Dilantin)
- Primidone
- Pyriméthamine
- Bactrim
- Quinidine
- Sulindac

Tableau n°3 : Principales étiologies de polyadénopathies		
Etiologies infectieuses	Bactériennes	Mycobactéries : tuberculose surtout ou infection à mycobactérie non tuberculeuse chez l'immunodéprimé (Sida, déficit immunitaires primitifs) syphilis, brucellose
	Virales	Primo-infection EBV, CMV, VIH Rubéole, rougeole, adénovirus, varicelle
	Parasitaires	Primo-infection toxoplasmose Leishmaniose viscérale
Etiologies non infectieuses	Hémopathies malignes	Leucémies aigües Lymphomes malins hodgkiniens ou non hodgkiniens Syndromes lymphoprolifératifs chroniques
	Maladies inflammatoires	Lypus érythémateux disséminé Maladie de Still Sacroïdose Adénite nécrosante de Kikuchi
	médicaments	Réaction de type hypersensibilité retardée Apparaît souvent au 9 ^{ème} - 15 ^{ème} jour de la prise médicamenteuse Souvent associé à : fièvre, myalgies, arthralgie, éruption, syndrome inflammatoire biologique, hyperéosinophile, présence de lymphocytes activés à l'hémogramme Molécules le plus souvent impliquées : antibiotiques (aminopénicillines et dérivés, céphalosporines, sulfamides), anticomitiaux (phénytoïne carbamazépine), allopurinol, anti-inflammatoires non stéroïdiens

QCM

Une adénopathie correspond à une:

- A. Augmentation du volume d'un ganglion
- B. Augmentation de la taille d'un ganglion de plus de 1cm si de siège inguinal
- C. Hypertrophie sous cutanée d'une masse graisseuse
- D. Augmentation de la taille d'un ganglion de plus de 1,5cm si de siège épitrochléen
- E. Hypertrophie du lobe droit de la glande thyroïde

QCM

Une adénopathie correspond à une:

- A. Augmentation du volume d'un ganglion
- B. Augmentation de la taille d'un ganglion de plus de 1cm si de siège inguinal
- C. Hypertrophie sous cutanée d'une masse graisseuse
- D. Augmentation de la taille d'un ganglion de plus de 1,5cm si de siège épitrochléen
- E. Hypertrophie du lobe droit de la glande thyroïde

QCM

Un ganglion est considéré comme pathologique à partir de:

- A. 0,5 cm
- B. 1 cm
- C. 2 cm
- D. 2,5 cm
- E. 3 cm

QCM

Un ganglion est considéré comme pathologique à partir de:

- A. 0,5 cm
- B. 1 cm**
- C. 2 cm
- D. 2,5 cm
- E. 3 cm

QCM

Une adénopathie est pathologique :

- A. Si sa taille dépasse 1 cm
- B. Lorsqu'elle siège dans le creux Sus claviculaire gauche
- C. Si elle évolue depuis plus de 3 semaines
- D. Lorsqu'elle siège au niveau épitrochléen
- E. Quelque soit le siège et la taille

QCM

Une adénopathie est pathologique :

- A. Si sa taille dépasse 1 cm
- B. Lorsqu'elle siège dans le creux Sus claviculaire gauche
- C. Si elle évolue depuis plus de 3 semaines
- D. Lorsqu'elle siège au niveau épitrochléen
- E. Quelque soit le siège et la taille

QCM

Les aires de palpation des adénopathies :

- A. Aires épitrochléennes
- B. Aires trochantériennes
- C. Aires palmaires
- D. Aires axillaires
- E. Aires pré-tragiennes

QCM

Les aires de palpation des adénopathies :

- A. Aires épitrochléennes
- B. Aires trochantériennes
- C. Aires palmaires
- D. Aires axillaires
- E. Aires pré-tragiennes

QCM

A propos du diagnostic positif d'une adénopathie superficielle :

- A. Est souvent clinique
- B. Nécessite parfois un bilan radiologique
- C. Nécessite une radiographie thoracique
- D. Nécessite une échographie abdominale
- E. Nécessite la pratique d'un PET scanner

QCM

A propos du diagnostic positif d'une adénopathie superficielle :

- A. Est souvent clinique
- B. Nécessite parfois un bilan radiologique
- C. Nécessite une radiographie thoracique
- D. Nécessite une échographie abdominale
- E. Nécessite la pratique d'un PET scanner

QCM

Les propositions exactes sont :

- A. Les ganglions inguinaux sont considérés comme pathologiques lorsque leur taille est > 1 cm
- B. Les ganglions épitrochléens sont considérés pathologiques quelle que soit leur taille.
- C. Les ganglions sus claviculaires sont considérés pathologiques lorsque la taille est > 1.5 cm.
- D. Une adénopathie est dite chronique si la durée d'évolution est supérieure à 3 semaines.
- E. La démarche étiologique devant une adénopathie est la même qu'elle soit isolée ou multiple

QCM

Les propositions exactes sont :

- A. Les ganglions inguinaux sont considérés comme pathologiques lorsque leur taille est > 1 cm
- B. Les ganglions épitrochléens sont considérés pathologiques quelle que soit leur taille.
- C. Les ganglions sus claviculaires sont considérés pathologiques lorsque la taille est > 1.5 cm.
- D. Une adénopathie est dite chronique si la durée d'évolution est supérieure à 3 semaines.
- E. La démarche étiologique devant une adénopathie est la même qu'elle soit isolée ou multiple

QCM

Le diagnostic positif d'une adénopathie superficielle se fait par :

- A. Inspection
- B. Palpation
- C. La pratique d'une radiographie thoracique
- D. La pratique d'une échographie abdominale
- E. La pratique d'un scanner thoracique

QCM

Le diagnostic positif d'une adénopathie superficielle se fait par :

- A. Inspection
- B. Palpation**
- C. La pratique d'une radiographie thoracique
- D. La pratique d'une échographie abdominale
- E. La pratique d'un scanner thoracique

QCM

A propos de l'examen clinique des aires ganglionnaires:

- A. Il est indispensable d'examiner toutes les aires ganglionnaires
- B. En présence d'ADP superficielles la recherche d'hépto-splénomégalie n'est pas indispensable
- C. L'examen des ganglions inguinaux se fait chez un patient couché
- D. En présence d'ADP il faut toujours compléter par une biopsie ganglionnaire
- E. La présence d'ADP axillaires nécessite un examen ORL complet

QCM

A propos de l'examen clinique des aires ganglionnaires:

- A. Il est indispensable d'examiner toutes les aires ganglionnaires
- B. En présence d'ADP superficielles la recherche d'hépto-splénomégalie n'est pas indispensable
- C. L'examen des ganglions inguinaux se fait chez un patient couché
- D. En présence d'ADP il faut toujours compléter par une biopsie ganglionnaire
- E. La présence d'ADP axillaires nécessite un examen ORL complet

QCM

A propos des adénopathies cervicales :

- A. L'examen clinique doit intéresser les 6 groupes ganglionnaires cervicaux
- B. L'examen doit être complété systématiquement par un examen de la sphère ORL
- C. Peuvent être associés à un cancer du cavum
- D. Une biopsie ganglionnaire est indispensable quel que soit l'étiologie évoquée
- E. Un bilan biologique est nécessaire

QCM

A propos des adénopathies cervicales :

- A. L'examen clinique doit intéresser les 6 groupes ganglionnaires cervicaux
- B. L'examen doit être complété systématiquement par un examen de la sphère ORL
- C. Peuvent être associés à un cancer du cavum
- D. Une biopsie ganglionnaire est indispensable quel que soit l'étiologie évoquée
- E. Un bilan biologique est nécessaire

QCM

Parmi les caractéristiques suivantes quelles sont celles nécessaires à l'orientation clinique

- A. La taille
- B. La consistance
- C. L'adhérence aux plans profonds
- D. La présence des signes inflammatoires locaux
- E. La sensibilité

QCM

Parmi les caractéristiques suivantes quelles sont celles nécessaires à l'orientation clinique

- A. La taille
- B. La consistance
- C. L'adhérence aux plans profonds
- D. La présence des signes inflammatoires locaux
- E. La sensibilité

QCM

Parmi les diagnostics différentiels d'une adénopathie cervicale:

- A. Un kyste branchial
- B. Une tuméfaction costale
- C. Une hydrosadénite
- D. Un neurinome
- E. Une grande corne de l'os hyoïde

QCM

Parmi les diagnostics différentiels d'une adénopathie cervicale:

- A. Un kyste branchial
- B. Une tuméfaction costale
- C. Une hydrosadénite
- D. Un neurinome
- E. Une grande corne de l'os hyoïde

QCM

Parmi les diagnostics différentiels d'une adénopathie cervicale:

- A. Une tumeur parotidienne
- B. Une tuméfaction costale
- C. Un kyste du tractus thyroïdienne
- D. Un kyste du cordon
- E. Une grande corne de l'os hyoïde

QCM

Parmi les diagnostics différentiels d'une adénopathie cervicale:

- A. Une tumeur parotidienne
- B. Une tuméfaction costale
- C. Un kyste du tractus thyroïdienne
- D. Un kyste du cordon
- E. Une grande corne de l'os hyoïde

QCM

Parmi les diagnostics différentiels d'une adénopathie axillaire:

- A. Un abcès
- B. Une digitation du muscle grand dentelé
- C. Un kyste du cordon
- D. Un neurofibrome
- E. Une grande corne de l'os hyoïde

QCM

Parmi les diagnostics différentiels d'une adénopathie axillaire:

- A. Un abcès
- B. Une digitation du muscle grand dentelé
- C. Un kyste du cordon
- D. Un neurofibrome
- E. Une grande corne de l'os hyoïde

QCM

Parmi les diagnostics différentiels d'une adénopathie inguinale:

- A. Une hernie crurale
- B. Un kyste branchial
- C. Un lipome
- D. Un anévrisme vasculaire
- E. Digitations musculaires du grand dentelé

QCM

Parmi les diagnostics différentiels d'une adénopathie inguinale:

- A. Une hernie crurale
- B. Un kyste branchial
- C. Un lipome
- D. Un anévrisme vasculaire
- E. Digitations musculaires du grand dentelé

QCM

En faveur du caractère malin d'une adénopathie :

- A. Taille > 4cm
- B. Consistance ferme
- C. Signes inflammatoires locaux
- D. Adhérence au plan profond
- E. Modifications rapides du volume

QCM

En faveur du caractère malin d'une adénopathie :

- A. Taille > 4cm
- B. Consistance ferme
- C. Signes inflammatoires locaux
- D. Adhérence au plan profond
- E. Modifications rapides du volume

QCM

En faveur du caractère malin d'une adénopathie :

- A. Le caractère compressif
- B. La consistance molle
- C. Le caractère douloureux
- D. La mobilité au plan profond et superficiel
- E. Limites floues

QCM

En faveur du caractère malin d'une adénopathie :

- A. Le caractère compressif
- B. La consistance molle
- C. Le caractère douloureux
- D. La mobilité au plan profond et superficiel
- E. Limites floues

QCM

Parmi les localisations des adénoapthies suivantes, laquelle traduit toujours une pathologie néoplasique :

- A. Inguinale
- B. Axillaires
- C. Sous mentonnières
- D. Sus claviculaire gauche
- E. Jugulo-carotidiennes

QCM

Parmi les localisations des adénoapthies suivantes, laquelle traduit toujours une pathologie néoplasique :

- A. Inguinale
- B. Axillaires
- C. Sous mentonnières
- D. Sus claviculaire gauche**
- E. Jugulo-carotidiennes

QCM

Deux localisations ganglionnaires sont considérées pathologiques quelque soit la taille:

- A. Épitrochléenne
- B. Sus claviculaire
- C. Inguinale
- D. Axillaire
- E. Rétro-auriculaire

QCM

Deux localisations ganglionnaires sont considérées pathologiques quelque soit la taille:

- A. Épitrochléenne
- B. Sus claviculaire
- C. Inguinale
- D. Axillaire
- E. Rétro-auriculaire

QCM

Devant une adénopathie localisée les examens complémentaires sont demandés :

- A. De façon systématique
- B. En l'absence d'étiologie au terme de l'examen clinique
- C. Devant la présence de signes généraux
- D. En cas d'adénopathie suspecte de malignité
- E. Toutes les propositions sont justes

QCM

Devant une adénopathie localisée les examens complémentaires sont demandés :

- A. De façon systématique
- B. En l'absence d'étiologie au terme de l'examen clinique
- C. Devant la présence de signes généraux
- D. En cas d'adénopathie suspecte de malignité
- E. Toutes les propositions sont justes

QCM

Devant une adénopathie localisée la ponction ganglionnaire :

- A. Permet de retenir le diagnostic de lymphome
- B. Permet l'étude cytologique d'une adénopathie
- C. A un intérêt diagnostique dans les adénites à pyogènes
- D. Est réalisée sous anesthésie général
- E. Peut remplacer la biopsie dans les pathologies tumorales

QCM

Devant une adénopathie localisée la ponction ganglionnaire :

- A. Permet de retenir le diagnostic de lymphome
- B. Permet l'étude cytologique d'une adénopathie
- C. A un intérêt diagnostique dans les adénites à pyogènes
- D. Est réalisée sous anesthésie général
- E. Peut remplacer la biopsie dans les pathologies tumorales

QCM

En cas de polyadénopathie superficielle, les examens complémentaires à demander en première intention:

- A. Un hémogramme
- B. Dosage de la CRP et de la vitesse de sédimentation
- C. Une biopsie ganglionnaire
- D. Une tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne
- E. Une sérologie HIV

QCM

En cas de polyadénopathie superficielle, les examens complémentaires à demander en première intention:

- A. Un hémogramme
- B. Dosage de la CRP et de la vitesse de sédimentation
- C. Une biopsie ganglionnaire
- D. Une tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne
- E. Une sérologie HIV

QCM

A propos de bilan de deuxième intention en présence d'adénopathies superficielles multiples:

- A. Demandé si bilan de 1^{ère} intention revient négatif
- B. Comporte NFS, bilan hépatique et un bilan inflammatoire
- C. Comporte un bilan immunologique
- D. Une TDM et/ou PET scanner est indiqué
- E. Une biopsie ganglionnaire est indiquée toujours

QCM

A propos de bilan de deuxième intention en présence d'adénopathies superficielles multiples:

- A. Demandé si bilan de 1^{ère} intention revient négatif
- B. Comporte NFS, bilan hépatique et un bilan inflammatoire
- C. Comporte un bilan immunologique
- D. Une TDM et/ou PET scanner est indiqué
- E. Une biopsie ganglionnaire est indiquée toujours

QCM

Devant une adénopathie jugulo-carotidienne haute unilatérale de taille >2 cm, vous demandez en première intention:

- A. Numération-formule sanguine
- B. Examen ORL spécialisé
- C. Biopsie ganglionnaire
- D. Echographie abdominale
- E. Cytoponction ganglionnaire

QCM

Devant une adénopathie jugulo-carotidienne haute unilatérale de taille >2 cm, vous demandez en première intention:

- A. Numération-formule sanguine
- B. Examen ORL spécialisé**
- C. Biopsie ganglionnaire
- D. Echographie abdominale
- E. Cytoponction ganglionnaire

QCM

Un cancer de la langue peut être exprimé par des ADP:

- A. Retro auriculaires
- B. Jugulaires
- C. Sous maxillaires
- D. Sus claviculaires gauches
- E. Cervicales postérieurs

QCM

Un cancer de la langue peut être exprimé par des ADP:

- A. Retro auriculaires
- B. Jugulaires
- C. Sous maxillaires
- D. Sus claviculaires gauches
- E. Cervicales postérieurs

QCM

La présence d'adénopathies inguinales doit faire évoquer :

- A. Une tumeur du vagin
- B. Une infection du périnée
- C. Un abcès de la paroi thoracique
- D. Une tumeur du colon
- E. Un abcès de la fesse

QCM

La présence d'adénopathies inguinales doit faire évoquer :

- A. Une tumeur du vagin
- B. Une infection du périnée
- C. Un abcès de la paroi thoracique
- D. Une tumeur du colon
- E. Un abcès de la fesse

QCM

Une adénopathie sus claviculaire gauche peut être associée à une tumeur :

- A. Colique
- B. Pulmonaire
- C. Utérine
- D. Pancréatique
- E. Médiastin antérieur

QCM

Une adénopathie sus claviculaire gauche peut être associée à une tumeur :

- A. Colique
- B. Pulmonaire
- C. Utérine
- D. Pancréatique
- E. Médiastin antérieur

QCM

Une adénopathie sus claviculaire droite peut être associée à :

- A. Tumeur rénale
- B. Cancer du poumon
- C. Lymphome médiastinale
- D. Thymome
- E. Tumeur testiculaire

QCM

Une adénopathie sus claviculaire droite peut être associée à :

- A. Tumeur rénale
- B. Cancer du poumon
- C. Lymphome médiastinale
- D. Thymome
- E. Tumeur testiculaire

QCM

Parmi les propositions suivantes la ou les quelle(s) sont juste(s):

- A. Une adénopathie axillaire peut révéler un cancer du sein
- B. Les ADP épitrochléennes sont toujours pathologiques
- C. Les ADP cervicales hautes avec épistaxis peuvent être révélatrices d'un cancer du cavum
- D. Les ADP épitrochléennes sont associées aux infections du bras
- E. Le ganglion de troisier doit chercher une tumeur de l'œsophage

QCM

Parmi les propositions suivantes la ou les quelle(s) sont juste(s):

- A. Une adénopathie axillaire peut révéler un cancer du sein
- B. Les ADP épitrochléennes sont toujours pathologiques
- C. Les ADP cervicales hautes avec épistaxis peuvent être révélatrices d'un cancer du cavum
- D. Les ADP épitrochléennes sont associées aux infections du bras
- E. Le ganglion de troisier doit chercher une tumeur de l'œsophage

QCM

Une adénopathie à Pyogène est:

- A. Principalement dû à des bacilles gram négatif
- B. Associée à des signes inflammatoires loco-régionaux
- C. Une porte d'entrée est souvent associée
- D. La ponction ganglionnaire est utile pour le diagnostic microbiologique
- E. Son traitement comporte toujours un drainage chirurgical

QCM

Une adénopathie à Pyogène est:

- A. Principalement dû à des bacilles gram négatif
- B. Associée à des signes inflammatoires loco-régionaux
- C. Une porte d'entrée est souvent associée
- D. La ponction ganglionnaire est utile pour le diagnostic microbiologique
- E. Son traitement comporte toujours un drainage chirurgical

QCM

La maladie des griffes du chat est:

- A. Une pathologie d'inoculation
- B. Associé à une griffure ou morsure de chat
- C. Principalement lié à une CGP
- D. Caractérisée par des adénopathies aiguës
- E. Son traitement repose sur une antibiothérapie type Azithromycine

QCM

La maladie des griffes du chat est:

- A. Une pathologie d'inoculation
- B. Associé à une griffure ou morsure de chat
- C. Principalement lié à une CGP
- D. Caractérisée par des adénopathies aiguës
- E. Son traitement repose sur une antibiothérapie type Azithromycine

QCM

A propos de la maladie des griffes du chat:

- A. La période d'incubation est de 2 mois
- B. Les adénopathies sont d'allure non inflammatoire
- C. Un état subfébrile est souvent associé
- D. Le diagnostic est confirmé par PCR mettant en évidence Bartonella henselae
- E. La biopsie exérèse de l'adénopathie met en évidence une lymphadénite nodulaire abcédée

QCM

A propos de la maladie des griffes du chat:

- A. La période d'incubation est de 2 mois
- B. Les adénopathies sont d'allure non inflammatoire
- C. Un état subfébrile est souvent associé
- D. Le diagnostic est confirmé par PCR mettant en évidence *Bartonella henselae*
- E. La biopsie exérèse de l'adénopathie met en évidence une lymphadénite nodulaire abcédée

QCM

Une adénopathie d'inoculation peut se voir en cas de:

- A. La maladie des griffes du chat
- B. Morsure de chien (Pasteurellose)
- C. La Tularémie
- D. La Rickettsiose
- E. Infection à staphylocoque

QCM

Une adénopathie d'inoculation peut se voir en cas de:

- A. La maladie des griffes du chat
- B. Morsure de chien (Pasteurellose)
- C. La Tularémie
- D. La Rickettsiose
- E. Infection à staphylocoque

QCM

Les adénopathies médiastinales sont fréquentes dans :

- A. Maladie de vaquez
- B. Lymphome de Hodgkin
- C. Myélome multiple
- D. Leucémie myéloïde chronique
- E. Leucémie aigue lymphoblastique

QCM

Les adénopathies médiastinales sont fréquentes dans :

- A. Maladie de vaquez
- B. Lymphome de Hodgkin**
- C. Myélome multiple
- D. Leucémie myéloïde chronique
- E. Leucémie aigue lymphoblastique**

QCM

Les éléments suivants sont en faveur de l'origine tuberculeuse des adénopathies:

- A. D'allure très inflammatoire
- B. Le plus souvent cervicales
- C. Le plus souvent bilatérales
- D. Le plus souvent volumineuses
- E. Ces adénopathies évoluent toujours vers une fistulisation cutanée

QCM

Les éléments suivants sont en faveur de l'origine tuberculeuse des adénopathies:

- A. D'allure très inflammatoire
- B. **Le plus souvent cervicales**
- C. Le plus souvent bilatérales
- D. **Le plus souvent volumineuses**
- E. Ces adénopathies évoluent toujours vers une fistulisation cutanée

QCM

En faveur de diagnostic de mononucléose infectieuse chez un enfant ayant des adénopathies multiples:

- A. Les adénopathies sont souvent cervicales
- B. Associé à une angine pseudomembraneuse
- C. Présence d'une splénomégalie très volumineuse
- D. Une hyperleucocytose à prédominance PNN
- E. Une hyperlymphocytose

QCM

En faveur de diagnostic de mononucléose infectieuse chez un enfant ayant des adénopathies multiples:

- A. Les adénopathies sont souvent cervicales
- B. Associé à une angine pseudomembraneuse
- C. Présence d'une splénomégalie très volumineuse
- D. Une hyperleucocytose à prédominance PNN
- E. Une hyperlymphocytose

QCM

Une polyadénopathie peut se voir en cas des infections virales suivantes:

- A. Primo infection par le VIH
- B. EBV
- C. Infection par le CMV
- D. Tuberculose
- E. Leishmaniose viscérale

QCM

Une polyadénopathie peut se voir en cas des infections virales suivantes:

- A. Primo infection par le VIH
- B. EBV
- C. Infection par le CMV
- D. Tuberculose
- E. Leishmaniose viscérale

QCM

Le Syphilis primaire est:

- A. Une maladie sexuellement transmise
- B. Due à l'agent bactérien *Treponema pallidum*
- C. Associé à des adénopathies multiples
- D. Associé à une ADP volumineuse, inflammatoire et douloureuse
- E. Associé à un chancre syphilitique

QCM

Le Syphilis primaire est:

- A. Une maladie sexuellement transmise
- B. Due à l'agent bactérien *Treponema pallidum*
- C. Associé à des adénopathies multiples
- D. Associé à une ADP volumineuse, inflammatoire et douloureuse
- E. Associé à un chancre syphilitique

QCM

Dans les maladies sexuellement transmissibles suivantes les adénopathies sont caractérisées par:

- A. ADP inguinale unique volumineuse non inflammatoire et indolore dans la syphilis
- B. ADP inguinales inflammatoires et d'ulcérations multiples dans le chancre mou
- C. Due à l'*Hæmophilus ducreyi* dans la syphilis primaire
- D. Due à *Treponema pallidum* dans le chancre mou.
- E. Evoluant vers une fistulisation cutanée dans la maladie de Nicolas Favre ou lymphogranulomatose vénérienne

QCM

Dans les maladies sexuellement transmissibles suivantes les adénopathies sont caractérisées par:

- A. ADP inguinale unique volumineuse non inflammatoire et indolore dans la syphilis
- B. ADP inguinales inflammatoires et d'ulcérations multiples dans le chancre mou
- C. Due à l'*Hæmophilus ducreyi* dans la syphilis primaire
- D. Due à *Treponema pallidum* dans le chancre mou.
- E. Evoluant vers une fistulisation cutanée dans la maladie de Nicolas Favre ou lymphogranulomatose vénérienne

QCM

En plus d'une polyadénopathie, la brucellose associe:

- A. Un Tiphos
- B. Une fièvre ondulante suduro-algique
- C. Une splénomégalie modérée
- D. Une leucopénie
- E. Une sérologie de Vidal positive pour confirmation

QCM

En plus d'une polyadénopathie, la brucellose associe:

- A. Un Tuphos
- B. Une fièvre ondulante suduro-algique
- C. Une splénomégalie modérée
- D. Une leucopénie
- E. Une sérologie de Vidal positive pour confirmation

QCM

Parmi les pathologies suivantes, le (les) quelle (s) pourrait (ent) être évoquées devant des adénopathies cervicales et un syndrome mononucélosique :

- A. Mononucléose infectieuse
- B. Maladie de Hodgkin
- C. Toxoplasmose acquise
- D. Maladie de Griffe de chat
- E. Infection à cytomégalovirus

QCM

Parmi les pathologies suivantes, le (les) quelle (s) pourrait (ent) être évoquées devant des adénopathies cervicales et un syndrome mononucélosique :

- A. Mononucléose infectieuse**
- B. Maladie de Hodgkin
- C. Toxoplasmose acquise**
- D. Maladie de Griffe de chat
- E. Infection à cytomégalovirus**

QCM

L'association splénomégalie, adénopathies cervicales peut être observée dans:

- A. La Leucémie myéloïde chronique (LMC)
- B. L'aplasie médullaire
- C. La leucémie lymphoïde chronique (LLC)
- D. La leucémie aigue
- E. La maladie de Minkowski chauffard

QCM

L'association splénomégalie, adénopathies cervicales peut être observée dans:

- A. La Leucémie myéloïde chronique (LMC)
- B. L'aplasie médullaire
- C. La leucémie lymphoïde chronique (LLC)
- D. La leucémie aigue
- E. La maladie de Minkowski chauffard

QCM

La présence des adénopathies axillaires unilatérales gauches peut évoquer un(e):

- A. Carcinome-mammaire gauche
- B. Maladie-de-Griffe-de-chat
- C. Mononucléose-infectieuse
- D. Cancer testiculaire
- E. Syphilis-primaire

QCM

La présence des adénopathies axillaires unilatérales gauches peut évoquer un(e):

- A. Carcinome-mammaire gauche
- B. Maladie-de-Griffe-de-chat
- C. Mononucléose-infectieuse
- D. Cancer testiculaire
- E. Syphilis-primaire

QCM

Une adénopathie localisée peut évoquer:

- A. Leucémie lymphoïde chronique
- B. Tuberculose ganglionnaire
- C. Infection de voisinage
- D. Maladie de Griffes du chat
- E. Mononucléose infectieuse

QCM

Une adénopathie localisée peut évoquer:

- A. Leucémie lymphoïde chronique
- B. Tuberculose ganglionnaire
- C. Infection de voisinage
- D. Maladie de Griffes du chat
- E. Mononucléose infectieuse

QCM

Les diagnostics à évoquer chez un patient se présentant avec une polyadénopathie axillaire et inguinale bilatérale

- A. Métastase d'un cancer digestif
- B. Métastase d'un cancer de la prostate
- C. Infection par le VIH
- D. Lymphome de Hodgkin
- E. Connectivite

QCM

Les diagnostics à évoquer chez un patient se présentant avec une polyadénopathie axillaire et inguinale bilatérale

- A. Métastase d'un cancer digestif
- B. Métastase d'un cancer de la prostate
- C. Infection par le VIH
- D. Lymphome de Hodgkin
- E. Connectivite

QCM

Devant une adénopathie cervicale isolée, vous évoquez le diagnostic de tuberculose ganglionnaire devant la présence de:

- A. Autres localisations extra ganglionnaires
- B. Signes d'imprégnation tuberculeuse
- C. Présence de granulome sans nécrose caséuse à l'histologie
- D. Fistulisation
- E. Altération de l'état général

QCM

Devant une adénopathie cervicale isolée, vous évoquez le diagnostic de tuberculose ganglionnaire devant la présence de:

- A. Autres localisations extra ganglionnaires
- B. Signes d'imprégnation tuberculeuse
- C. Présence de granulome sans nécrose caséuse à l'histologie
- D. Fistulisation
- E. Altération de l'état général

QCM

La présence des adénopathies inguinales fistulisées peut évoquer un (e):

- A. Primo infection par la syphilis
- B. Abscess anal
- C. Chancre mou
- D. Leucémie aigue
- E. Tuberculose

QCM

La présence des adénopathies inguinales fistulisées peut évoquer un (e):

- A. Primo infection par la syphilis
- B. Abscès anal
- C. **Chancre mou**
- D. Leucémie aigue
- E. **Tuberculose**

QCM

Concernant les adénopathies dans la sarcoïdose, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Elles sont souvent superficielles, bilatérales, fermes et indolores
- B. Elles sont inflammatoires, douloureuses et suppuratives dans la majorité des cas
- C. Elles s'associent fréquemment à des atteintes pulmonaires, cutanées ou oculaires
- D. Elles surviennent dans environ 20 % des cas de sarcoïdose
- E. Leur histologie montre un granulome épithélioïde et giganto-cellulaire sans nécrose

QCM

Concernant les adénopathies dans la sarcoïdose, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Elles sont souvent superficielles, bilatérales, fermes et indolores
- B. Elles sont inflammatoires, douloureuses et suppuratives dans la majorité des cas
- C. Elles s'associent fréquemment à des atteintes pulmonaires, cutanées ou oculaires
- D. Elles surviennent dans environ 20 % des cas de sarcoïdose
- E. Leur histologie montre un granulome épithélioïde et giganto-cellulaire sans nécrose

QCM

Parmi les anomalies suivantes, lesquelles sont caractéristiques de la sarcoïdose ?

- A. Anergie tuberculinique
- B. Hypercalcémie
- C. Présence d'un granulome caséeux nécrosant
- D. Élévation de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA)
- E. Granulome épithélioïde et giganto-cellulaire sans nécrose

QCM

Parmi les anomalies suivantes, lesquelles sont caractéristiques de la sarcoïdose ?

- A. Anergie tuberculinique
- B. Hypercalcémie
- C. Présence d'un granulome caséeux nécrosant
- D. Élévation de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA)
- E. Granulome épithélioïde et giganto-cellulaire sans nécrose

QCM

Lesquelles des pathologies suivantes peuvent être responsables d'adénopathies d'origine inflammatoire ?

- A. Lupus érythémateux systémique (LES)
- B. Polyarthrite rhumatoïde (PR)
- C. Maladie de Still
- D. Syndrome de Kawasaki chez l'enfant
- E. Hyperthyroïdie de Basedow

QCM

Lesquelles des pathologies suivantes peuvent être responsables d'adénopathies d'origine inflammatoire ?

A. Lupus érythémateux systémique (LES)

B. Polyarthrite rhumatoïde (PR)

C. Maladie de Still

D. Syndrome de Kawasaki chez l'enfant

E. Hyperthyroïdie de Basedow

Cas clinique 1

Enfant âgé de 4 ans, ramené aux urgences pour fièvre résistante aux antibiotiques apparue depuis 1 semaine.

L'examen clinique :

- * Adénopathies cervicales bilatérales de 2 cm de grand axe,
- * Splénomégalie de 2 cm du rebord costal
- * Tâches ecchymotiques aux membres inférieurs

Cas clinique 1

QCM1 : L'examen complémentaire de première intention à demander:

- A. Scanner cervico-thoraco-abdominal
- B. NFS+ frottis sanguin
- C. Echographie cervicale
- D. Cytoponction ganglionnaire
- E. Biopsie ganglionnaire

Cas clinique 1

QCM1 : L'examen complémentaire de première intention à demander:

- A. Scanner cervico-thoraco-abdominal
- B. NFS+ frottis sanguin**
- C. Echographie cervicale
- D. Cytoponction ganglionnaire
- E. Biopsie ganglionnaire

Cas clinique 1

La CRP était élevée, l'échographie cervicale montre des adénopathies cervicales bilatérales, la plus grande de 2 cm de grand axe. NFS montre : GB : 30 000/mm³ (PNN30%, Lymphocytes 20%, Monocytes 10%, blastes 40%)

QCM2 : Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Leucémie lymphoïde chronique
- B. Lymphome de Hodgkin
- C. Leucémie aigue
- D. Leucémie myéloïde chronique
- E. Lymphome non Hdgkinien

Cas clinique 1

La CRP était élevée, l'échographie cervicale montre des adénopathies cervicales bilatérales, la plus grande de 2 cm de grand axe. NFS montre : GB : 30 000/mm³ (PNN30%, Lymphocytes 20%, Monocytes 10%, blastes 40%)

QCM2 : Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Leucémie lymphoïde chronique
- B. Lymphome de Hodgkin
- C. Leucémie aigue**
- D. Leucémie myéloïde chronique
- E. Lymphome non Hdgkinien

Cas clinique 1

QCM3 : La confirmation du diagnostic repose sur:

- A. Biopsie ostéo-médullaire
- B. Myélogramme
- C. Biopsie ganglionnaire
- D. Scanner cervico-abdominal
- E. Cytoponction ganglionnaire

Cas clinique 1

QCM3 : La confirmation du diagnostic repose sur:

- A. Biopsie ostéo-médullaire
- B. Myélogramme**
- C. Biopsie ganglionnaire
- D. Scanner cervico-abdominal
- E. Cytoponction ganglionnaire

Cas clinique 2

Monsieur Ali âgé de 65 ans, consulte pour la découverte fortuite de tuméfaction cervicale.

L'examen clinique :

- * BEG avec IK à 90%, apyrétique
- * Multiples adénopathies cervicales, axillaires et inguinales bilatérales et symétriques de 1 à 2 cm de grand axe,
- * Splénomégalie à 2 cm du rebord costal
- * Le reste de l'examen est sans particularité

Cas clinique 2

QCM1 : L'examen complémentaire de première intention à demander:

- A. Scanner cervico-thoraco-abdominal
- B. NFS+ frottis sanguin
- C. Echographie cervicale
- D. Cytoponction ganglionnaire
- E. Biopsie ganglionnaire

Cas clinique 2

QCM1 : L'examen complémentaire de première intention à demander:

- A. Scanner cervico-thoraco-abdominal
- B. NFS+ frottis sanguin**
- C. Echographie cervicale
- D. Cytoponction ganglionnaire
- E. Biopsie ganglionnaire

Cas clinique 2

NFS montre : GB : 75 000/mm³ (PNN 10%, Lymphocytes 85%, Monocytes 5%, Ombre de Gumprecht)

QCM2 : Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Leucémie lymphoïde chronique
- B. Lymphome de Hodgkin
- C. Leucémie aigue
- D. Leucémie myéloïde chronique
- E. Lymphome non Hdgkinien

Cas clinique 2

NFS montre : GB : 75 000/mm³ (PNN 10%, Lymphocytes 85%, Monocytes 5%, Ombre de Gumprecht)

QCM2 : Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Leucémie lymphoïde chronique**
- B. Lymphome de Hodgkin
- C. Leucémie aigue
- D. Leucémie myéloïde chronique
- E. Lymphome non Hdgkinien

Cas clinique 2

QCM3 : La confirmation du diagnostic repose sur:

- A. Biopsie ostéo-médullaire
- B. Myélogramme
- C. Biopsie ganglionnaire
- D. Scanner cervico-thoraco-abdominal
- E. Immunophénotypage des lymphocytes sanguins

Cas clinique 2

QCM3 : La confirmation du diagnostic repose sur:

- A. Biopsie ostéo-médullaire
- B. Myélogramme
- C. Biopsie ganglionnaire
- D. Scanner cervico-thoraco-abdominal
- E. Immunophénotypage des lymphocytes sanguins

MERCI POUR VOTRE ATTENTION